

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	後天免疫不全症候群 Acquired Immunodeficiency Syndrome; AIDS				
編號	A31000-Q03-W-J01	制定者	M9 李姿月	公布日期	97 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 4.2 版/15 頁	審查者	曾翊健	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解後天免疫不全症候群的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，提升更適切之照護能力，進而發揮最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

後天免疫不全症候群(Acquired Immuno Deficiency Syndrome, AIDS)俗稱愛滋病，主要由愛滋病毒(Human Immunodeficiency Virus, HIV)感染引起，是複雜度高且致命性的傳染疾病(WHO, 2015)。目前可分為兩型，HIV-1 和 HIV-2。HIV-1 是大多數國家中最主要造成愛滋病的病因。HIV-2 主要分布在西非。兩種病毒的致病力並不相同，感染 HIV-1 後超過 90% 的患者會在 10-12 年內發病成為愛滋病。感染 HIV-2 則往往沒有相關的病症。HIV 經由血液帶至全身，並破壞人類免疫系統 CD4，當血液中的病毒數量越來越多時，CD4 則會逐漸減少，致使身體的免疫力下降；當侵犯體內的 CD4 少於 200 cells/ μ^3 ，導致出現各種伺機性感染，甚至發生惡性腫瘤，進而喪失生命。

（二）症狀

感染愛滋病毒後，大致可以分為空窗期、急性感染期、潛伏期及發病期，期程的時間長短因人而異。

主題名稱	後天免疫不全症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-J01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	2/15

1. 空窗期

指的是愛滋病毒感染後，需要經過一段時間，血液才會產生愛滋病毒抗原及抗體，因此在感染的早期，可能因抗原/抗體尚未產生，而檢驗呈陰性反應，但此時體內愛滋病毒數量多、傳染力強。

2. 急性感染期

HIV感染初期，約近於一半感染者在感染後約 2-6 週內會產生特定的症狀，包括：發燒、喉嚨疼痛、疲倦、胃口不佳、噁心、嘔吐、腹瀉。這些症狀通常會持續 1-2 週後才會逐漸復原。大部分的HIV感染者在早期出現這些症狀時，並不會察覺其重要性。甚至有 30%-50%的HIV感染者在初期並不會出現症狀。

3. 潛伏期

(1)指感染後約 2-6 星期會出現感冒樣的原發性感染症狀。

(2)指感染愛滋病毒後到出現臨床症狀的期間，一般是 5-10 年(目前稱為隱形期或次臨床期)。愛滋病毒感染後的病程快慢不一，空窗期或潛伏期時，許多患者沒有症狀，患者可能繼續從事高危險性行為，因此成為愛滋病毒防治的漏洞。

4. 發病期

當CD₄ 在 200 cells/ μ^3 以下時，免疫力微弱至無法對抗各種伺機性感染，便進入愛滋病期。感染者一開始會出現皮膚、黏膜的病徵，帶狀疱疹、舌緣的毛髮狀白斑、脂漏性皮膚炎、卡波西氏肉瘤、口腔食道念珠菌感染、潰瘍性單純皰疹等。當CD₄ 繼續減少時，嚴重可能有致命的伺機性感染，例如：肺囊蟲肺炎、念珠菌、結核菌、卡波西式肉瘤、巨細胞及單純疱疹病毒等，以性行為傳染為最主要的傳染途徑。

(三) 常見檢查

1. HIV 抗原/抗體複合型檢驗篩檢：初步檢驗血液中是否有 HIV 抗體。

2. HIV-1/2 抗體免疫層析檢驗法：確認抗體是否為 HIV 感染。

(四) 常見治療

主題名稱	後天免疫不全症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-J01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	3/15

高效能抗愛滋病毒療法(Highly active antiretroviral therapy, HAART)，俗稱“雞尾酒療法”，意指使用三種以上抗愛滋病毒藥物合併治療的方法，也被稱為三合一療法，此療法能降低病毒量，進而提高免疫力，改善存活率和減少病毒抗藥性。藥物可分為五大類：

1. 核苷酸反轉錄酶抑制劑(Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors；NRTI)如：lamivudine、abacavir、tenofovir及Truvada、Kivexa、Combivir等複方藥。
2. 非核苷酸反轉錄酶抑制劑(Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors；NNRTI)如：efavirenz、nevirapine、rilpivirine、etravirine。
3. 蛋白酶抑制劑(Protease Inhibitor；PI)如：lopinavir/ritonavir、ritonavir、atazanavir、darunavir等。
4. 整合酶抑制劑(Integrase inhibitor；II)如：dolutegravir、raltegravir、Bictegravir。
5. CCR5 接受器阻斷劑(CCR5 receptor antagonist)如：Maraviroc。
6. 三合一複方藥錠：如 Triumeq、Atripla、Complera、Genvoya、Biktarvy、Odefsey。
7. 二合一複方藥錠：如 Juluca。

目前的雞尾酒療法，是根據感染者的病程、臨床及免疫功能狀況、生活及職業型態等，將數種同類或不同類的抗病毒藥物加以適當組合，以達到最大的抗病毒療效及避免愛滋病毒產生抗藥性。在合併藥物的選用上，傳統的三合一療法指的是(2 NRTI + 1 PI)。

8. 2024 年增加愛滋治療長效針劑，針對病情達控制、無針劑成分藥物抗藥性、無合併B型肝炎感染且有轉換針劑需求(如:每日口服愛滋抗病毒藥物有困難者)等符合使用條件之感染者能使用。

目前評估抗病毒藥物治療療效最好的方法是檢驗血液中愛滋病毒量(viral load)的變化，再佐以CD4 淋巴球數和臨床症狀。感染者在開始雞尾酒療法後，在 12 至 24 週內不但可使血中病毒量降至測不到的地步，並可使人體抵抗力(CD4)上升，從而提升整體的健康狀況，大幅延長了病人的存活。已有不少病人在規則的服

主題名稱	後天免疫不全症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-J01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	4/15

用雞尾酒療法一段時間後，目前的健康狀況幾乎與常人無異

(五) 護理問題

1. 保護能力改變／與免疫系統 CD4 受破壞有關。
2. 缺乏營養／與疲倦、胃口不佳有關。
3. 排便異常：腹瀉／與受到愛滋病毒感染有關。
4. 感到疲憊無力／與供氧不平衡有關。
5. 易感染／第二道防線不完善（免疫系統）。
6. 低自尊／與愛滋病帶原有關。
7. 照顧者感到緊張／擔心疾病預後有關。

(六) 護理措施

1. 保護能力改變／與免疫系統 CD4 受破壞有關。
 - (1) 監測生命徵象。
 - (2) 加強病人自我保護的知識（例如：勿單獨行動）。
 - (3) 指導家屬及主要照顧者協助病人完成自我照顧及給予病人適當保護（例如：床欄使用、保護性約束）。
 - (4) 指導家屬及主要照顧者不可單獨留下病人，如欲外出需告知其他家屬或護理人員，給予探視避免危險。
 - (5) 指導病人採漸進式活動，協助病人執行肢體主動或被動全關節運動。
 - (6) 評估病人體能上所能達成最大的控制力，並採取預防性措施將危險減至最低。
 - (7) 保持病房環境安全（例如：保持浴廁地面乾燥、走道通暢，光線充足）。
 - (8) 注意皮膚的保護，使用適量乳液，保護皮膚表層。
 - (9) 早、晚溫差大時，應添加衣物。
 - (10) 教導病人或主要照顧者預防感染的方法（例如：接觸病人前洗手、限制訪客、正確用藥、注意衛生、營養充足、盡量避免到公共場所），並評估瞭解的程度。

主題名稱	後天免疫不全症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-J01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	5/15

- (11) 建議每日攝取適當的水分，並注意飲食的清潔。
- (12) 加強病人個人衛生，提醒或協助每日的身體及口腔清潔。
- (13) 提供相關藥物的作用、副作用，衛教病人勿擅自更改藥量，或驟然停藥。

2. 缺乏營養／與疲倦、胃口不佳有關

- (1) 每星期測量體重，計算病人每日所需攝取熱量及實際食物攝取熱量。
- (2) 依醫囑監測血清白蛋白檢驗值變化。
- (3) 評估有無消化不良、腹脹、腹瀉情況。
- (4) 少量多餐一天約 4-6 餐，減少腹部鼓脹感和消化的負擔，以增加進食量。
- (5) 記錄每日進食量與輸出量，避免短時間大量進食以減少代謝的負擔。
- (6) 配合病人食物喜好選擇高蛋白質、高熱量食物。
- (7) 建議清淡飲食，避免辛辣、刺激性食物及避免選擇會增加唾液黏稠度（如：全脂奶、巧克力、蘇打）、需用力咀嚼（如：豆類、洋蔥、黃瓜、玉米）的食物、含咖啡因或酒精性的飲料（因會利尿可能導致脫水）。
- (8) 注意藥物所帶來的副作用，如噁心、嘔吐；可提供冷食有助於改善噁心、嘔吐情形。
- (9) 病人若無法達到理想熱量攝取時，與醫師討論，適量的增加靜脈輸液或補充高脂低醣飲食，蛋白質的攝取要適量或考慮給予管灌飲食。

3. 排便異常：腹瀉／與受到愛滋病毒感染有關

- (1) 向病人及主要照顧者說明腹瀉的原因，減輕病人及照顧者的焦慮。
- (2) 教導病人及主要照顧者觀察記錄大便形狀（鬆軟、水樣、含有黏膜、是否浮在水面上）、次數（隔多久一次）、量、顏色（是否有血絲）。
- (3) 建議病人及主要照顧者不要攝取牛奶方面製品，改用豆類製品。
- (4) 鼓勵病人飲用富有葡萄糖與電解質的液體（腹瀉新觀念：照常進食較清淡食物，讓髒東西排泄光；禁止醣類、發酵、油性等食物）。
- (5) 監測生命徵象的變化，並維持正常體溫。
- (6) 監測血中檢驗值的變化（如：電解質、白血球、白蛋白）。

主題名稱	後天免疫不全症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-J01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	6/15

- (7) 監測體重及記錄病人輸出入量，觀察皮膚彈性、有無脫水情形。
- (8) 依病情需要攝取所需水分或醫囑增加靜脈注射輸液，必要時與醫師商討會診營養師。
- (9) 若腹瀉嚴重時，依醫囑請病人禁食或給予止瀉藥物。
- (10) 注意肛門周圍及臀部皮膚清潔、乾燥，可用溫和的肥皂與水，給予皮膚護理，若皮膚有發紅情形，則塗抹凡士林以保護皮膚。
- (11) 若病人能開始進食時，教導病人及主要照顧者給予清淡、無刺激性的食物，且採取漸進式逐量增給。

4. 感到疲憊無力／與供氧不平衡有關

- (1) 評估疲勞程度、心理及情緒與疲勞程度之間的關係。
- (2) 鼓勵病人表達疲憊的感受度及內心感受予傾聽之，提供冥想或祈禱的運用以增加心理支持。
- (3) 評估病人之心理及情緒反應，及其對生活造成的影響。
- (4) 評估病人若為疾病或藥物造成之疲憊，給予安排一舒適安靜的環境，做適當的休息。
- (5) 評估病人 24 小時疲憊程度，記下精力最佳及精疲力盡的時間，瞭解活動與疲憊的相關性。
- (6) 教導病人及家屬瞭解活動的重要性，並協助規劃每日的活動計畫內容，包括自我照顧、運動與休閒活動。
- (7) 教導並監測適合病人的放鬆技巧與方式如按摩、冥想，可有效處理壓力。
- (8) 採漸進式的增加活動量，先由簡單的活動開始，待適應後再增加有氧運動，以增強病人的肌力、柔軟度、體適能及心肺功能。
- (9) 評估睡眠型態及品質，使獲得充分休息。
- (10) 評估目前家庭支持系統，若需要則協助安排合適之轉介機構。

5. 易感染／第二道防線不完善（免疫系統）

- (1) 接觸病人前洗手。

主題名稱	後天免疫不全症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-J01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	7/15

- (2) 監測生命徵象。
 - (3) 監測可顯示感染的實驗室檢查，並報告異常現象。
 - (4) 監測輸液注射部位有無感染情形。
 - (5) 指導病人及主要照顧者炎症症狀（紅、腫、熱、痛）及徵象（如：發燒、流膿）。
 - (6) 每當要與血液、體液（包括唾液）接觸時，需運用適當的隔離技術如戴口罩、手套、穿隔離衣。
 - (7) 視需要限制訪客或安置於隔離病房、個人房，保持環境乾淨，空氣品質良好，必要時做環境消毒。
 - (8) 指導病人及主要照顧者感染的危險因子（如：接觸病人前未洗手、傷口敷料滲濕、濫用藥物、衛生習慣差、營養不良、現存或潛在疾病）。
 - (9) 指導病人及主要照顧者預防感染的方法如：接觸病人前洗手，並評估其瞭解的程度。
 - (10) 執行侵入性治療，採無菌技術執行。
 - (11) 加強病人個人衛生，提醒或協助每日的身體清潔和口腔清潔。
 - (12) 依醫囑按時給予藥物如：抗生素。
 - (13) 與醫師討論儘早拔除侵入性治療的管路，以預防感染的發生。
 - (14) 評估病人營養狀況，教導選擇高熱量、高蛋白、高維生素飲食。
6. 低自尊／與愛滋病帶原有關
- (1) 瞭解病人的以往經驗及對自我認知程度。
 - (2) 維持一致性及真誠的態度，常探視表達關懷並注意環境安全。
 - (3) 多與病人接觸，建立良好治療性人際關係，以取得病人信任。
 - (4) 增加陪伴、主動傾聽、開放式問題，來促進病人表達。
 - (5) 定期會談，協助病人分析情境中之因素，以澄清價值，並能矯正負向之感受。
 - (6) 以不批判態度接受病人用憤怒來表達自己的挫折或感受。

主題名稱	後天免疫不全症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-J01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	8/15

(7) 病人陳述的感受消極、負向不正確且有扭曲的想法時，給予適時澄清及修正。

(8) 引導病人自我探索，描述真實與正向的自我評估，可矯正病人對自我錯誤的觀念。

(9) 對病人其它成就表示肯定，給予讚美、鼓勵，增加病人的信心恢復。

(10) 介紹行為、思想正向的病友給病人認識，互動與會談，彼此交換意見，調適因應事情的能力。

(11) 與病人共同擬定目標及治療的方式，讓病人擁有較高的自主性。

(12) 與家屬討論，評估病人的自我照顧能力，適當的給予協助，減少病人因無法完成造成的挫折感。

(13) 協助家屬成員了解病人，指導或修正病人的行為（勿用指責態度），改善病人人際關係、增加社交技巧。

(14) 若發現病人有退縮及拒絕的行為，應瞭解原因並協助解決。

(15) 鼓勵並促進病人參加同性質團體，彼此取得心靈的安慰及支持。

(16) 病人之自尊高於其能力，教導評估其失敗的原因並重新設定真實之目標，矯正扭曲之感受及重新正確評價自我。

(17) 協助病人發展因應失落壓力或環境因素造成的低自尊之策略。

(18) 預防負向的情緒，避免自傷。

7. 照顧者感到緊張／擔心疾病預後有關

(1) 與照顧者建立良好護病關係如：親切的稱呼、保持微笑、態度親切、溫和。

(2) 瞭解照顧者對可利用資源之瞭解程度，提供及加強相關照顧資訊及衛教單張。

(3) 評估其經濟能力，協助獲得社區之資源如社會局。

(4) 判斷照顧與被照顧者對接受資源協助之意願。

(5) 監測照顧者之抑鬱及壓力程度。

主題名稱	後天免疫不全症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-J01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	9/15

(6) 引導照顧者說出內心感受並以同理心傾聽之。

(7) 評估目前家庭支持系統，若需要則協助安排合適之轉介。

(8) 教導時間處理及利用方法如協助安排生活作息表，使有固定適當娛樂、休閒與部分社交活動。

(9) 教導維持每日活動及休息、睡眠時間的平衡。

(10) 教導照顧者學習或練習鬆弛技巧及轉移注意力。

(11) 鼓勵照顧者藉由宗教活動減輕緊張情緒，如聽佛經、聽詩歌。

(12) 提供照顧者對於被照顧者之相關訊息，如疾病原因、症狀、需求，有助於其調適及減輕不知所措的情緒。

(13) 對於照顧者適時給予鼓勵及支持正向行為，增加其信心、提升自尊，減少焦慮、壓力，促進自我發展。

(14) 協助照顧者與家庭成員協調其角色，並協助改變家庭狀況。

(15) 提供可諮詢之機構名稱與電話。

(七) 衛教指導

教導病人日常自我照顧的技巧及注意事項十分重要，衛教內容中還必須包括如何避免感染他人，實行安全性行為的建議。護理人員給予病人自我照顧衛教內容建議包含下列幾個重要事項：

1. 強調服藥治療的重要性：每天遵照醫師指示按時規律服藥，是保持健康狀況、提升免疫力唯一的有效方法。
2. 教導病人疾病進展的重要關鍵，包括：CD4 的指標、HIV 病毒量的高低、疾病變化的警訊、發病時會出現什麼症狀等。
3. 如何避免危險因子、有哪些因素會誘發病毒加速攻擊，如健康狀況不好、營養變差、壓力、感染疾病（性病、感冒、水痘等）、抽煙、喝酒等，都會降低免疫力，甚至加速 HIV 病毒的複製而急速惡化。
4. 日常生活中注意事項：

(1) 個人衛生方面：

主題名稱	後天免疫不全症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-J01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	10/15

- A. 注意個人基本衛生。
- B. 刷牙後可使用漱口水，以減少口腔念珠菌感染的機會。
- C. 洗澡時使用清潔殺菌劑，可減少皮膚受到感染的機會。
- D. 避免與人共用牙刷或刮鬍刀。

(2)環境方面：

- A. 避免到擁擠、髒亂、空氣不好或密閉式空調的地方。
- B. 避免到衛生環境差的地方或剛逢水災之處。
- C. 傳染性疾病流行時，儘量減少接觸的次數，建議帶上口罩。
- D. 保持居住環境的衛生。

5. 食物及飲水暴露：

- (1) 避免食用生的或未經煮熟的食物。
- (2) 不要直接喝湖水或溪流的水，也不可吞入游泳池的水。
- (3) 避免吃未完全煮熟的食物，多吃蛋白質食物及每天吃綜合維他命。
- (4) 避免飲用酒精類飲料及抽煙。

6. 建議實行良好的生活方式：

- (1) 避免因忙碌而熬夜。
- (2) 保持規律的起居習慣。
- (3) 維持固定的運動習慣及休閒活動。

7. 心理調適方面：

- (1) 保持良好的健康狀況，是使心情平穩的最佳方法。
- (2) 參加支持性團體，與最信任的人討論有關疾病的問題。
- (3) 相關的疾病問題可與社工、相關團體、精神科醫師及醫護人員討論。

8. 在日常生活中須知道哪些傳染途徑該事先預防或簡單消毒，以確保他人的安全。

9. 對使用注射藥癮者的建議：

- (1) 教導不可重複使用或與他人共用針頭、空針、稀釋液等器具。

主題名稱	後天免疫不全症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-J01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	11/15

(2)只使用可靠來源的無菌空針。

(3)教導注射前需要消毒注射部位，注射後空針需丟棄在安全的容器內。

10.教導常見症狀及初步處理的技巧：由於愛滋病隨時都可能出現身體不適的症狀，因此教導病人初步處理技巧，可降低病人的不安全感。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、 使用表單

(略)

五、 流程圖

(略)

主題名稱	後天免疫不全症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-J01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	12/15

六、參考資料

- (一) 洪靜如、陳瑛瑛、王永衛、王復德(2018)．某醫學中心人類免疫缺乏病毒感染病人之醫療照護相關感染．感染控制雜誌，28(2)，49-61。DOI: 10.6526/ICJ.201804_28(2).0001
- (二) 陳怜潔、劉玉玲、王琬詳、葉惠玲(2016)．一位僵直性脊椎炎手術個案之照護經驗．志為護理-慈濟護理雜誌，15(1)，103-113。
- (三) 郭雅萍、曾瓊誼(2018)．一位伺機性感染病人確診愛滋病之護理經驗．新臺北護理期刊，20(1)，101-110。DOI: 10.6540/NTJN.2018.1.009
- (四) 衛生福利部疾病管制署(2018)．愛滋病檢驗及治療指引第五版．台北：衛生福利部疾病管制署。
- (五) World Health Organization. (2015). Global summary of the HIV/AIDS epidemic, December 2014. 2015 年 12 月 30 日取自
http://www.who.int/hiv/data/epi_core_july2015.png?ua=1
- (六) Wan, N.W.Y., Wan, M.Z.W.M., Siew, H, G., Mahiran. M., Che, B.A.A., & Siti, A.A. (2019). Tualang honey ameliorates viral load, CD4 counts and improves quality of life in asymptomatic human immunodeficiency virus infected patients. Journal of Traditional and Complementary Medicine, 9(4), 149-256. DOI: 10.1016/j.jtcme.2018.05.003

七、附件

(略)

主題名稱	後天免疫不全症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-J01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	13/15

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.05.31	1.0	新制定	97 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
101.08.31	2.1	1.修改錯別字 2.醫護部改護理部	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	3.1	更新參考資料	103 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
104.08.31	3.2	增修第六項參考文獻資料	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.3	1. 第三項第(一)、(二)、(三)目更新部份內容。 2. 將參考文獻新增於內文。 3. 第六項參考資料增刪及修訂。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.4	1. 第三項說明內容部分修辭。 2. 更新第六項參考資料。	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.12.27	3.5	1. 第一項目的內容部分修辭。 2. 第三項一至四目內容說明增修訂。	106 年 12 月 27 日護理長會議通過
107.06.29	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.6	1. 第一項說明內容新增護理。 2. 第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.09.23	3.7	1. 第三項愛滋病檢驗及治療指引第四版修訂為第五版，故文獻皆更改為 2018。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。

主題名稱	後天免疫不全症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-J01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	14/15

修正日期	版本	修正說明	備註
		2. 第三項第八目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 3. 第六項參考資料修訂。	
109.08.18	3.8	1. 第一項說明內容文字修訂。 2. 第三項第四目之 6、7、第六目之 4(5)(7)(8) 說明內容文字修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過； 109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.10.19	3.9	第六項參考資料修訂。	110 年 10 月 07 日照護標準組會議通過； 110 年 10 月 13 日護理長會議通過；110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.09.06	4.0	1. 第三項第(一)、(二)、(三)、(四)目刪除內文文獻引用。 2. 第三項第(五)、(六)目修改護理問題用詞。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.09.05	4.1	1. 第三項第二目之 2.說明內容修訂。 2. 第三項第五目之 6、第六目之 6.護理問題修正。	112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過； 112 年 08 月 09 日護理長會議通過；112 年 09 月 05 日督導會議通過公布。
113.08.08	4.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.10.08	4.2	1.第三項第(一)、(二)、(三)、(四)目之 8、(五)目、(六) 修改護理問題用詞，內容修訂。	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過； 114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。

主題名稱	後天免疫不全症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-J01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	15/15

修正日期	版本	修正說明	備註